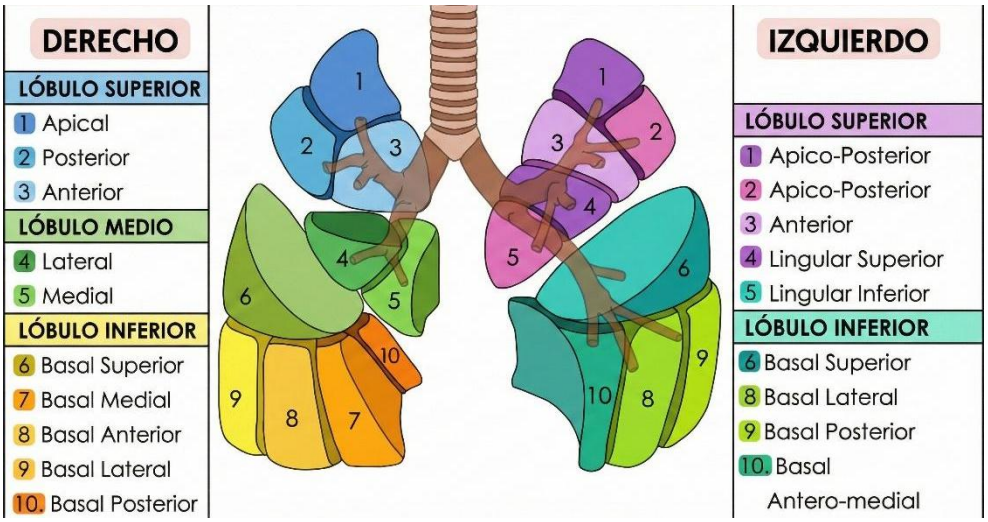
LOBECTOMÍA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Gabriela Lorenzo Dorta, Mª Goretti González Mesa, Sergio Tacoronte Pérez

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Es el procedimiento de elección para el tratamiento de varias patologías pulmonares, principalmente el cáncer de pulmón, aunque en algunas ocasiones es necesaria para el tratamiento de patología benigna.

Se trata de realizar la resección anatómica del lóbulo en cuestión, disecando y seccionando las estructuras broncovasculares (bronquio lobar, vena lobar y arteria lobar). Una vez seccionadas dichas estructuras, se escinde la cisura para separar el parénquima del resto del pulmón. Cuando se realiza la lobectomía como tratamiento oncológico se acompaña la técnica de una linfadenectomía hiliar y mediastínica.



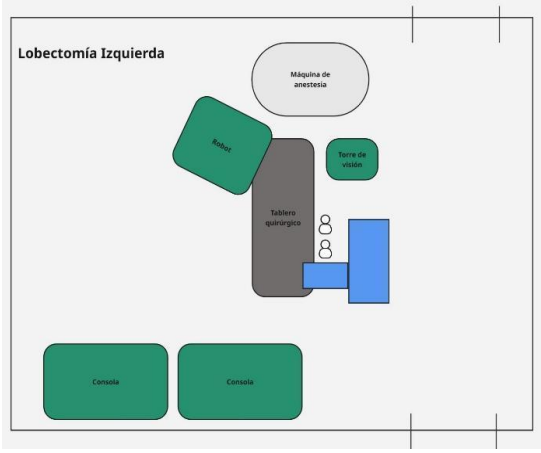
POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE

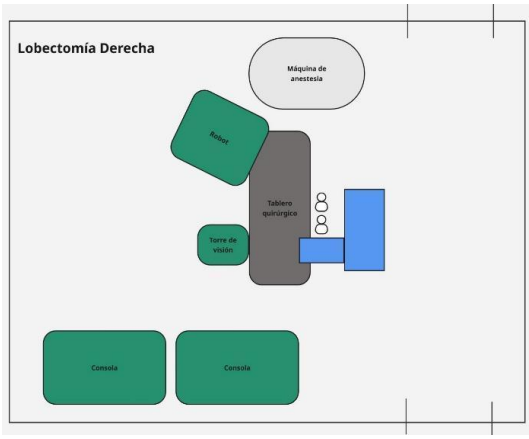
- Decúbito lateral con lado afecto arriba.
- Brazos flexionados hacia la cabeza. Brazo superior en pernera e inferior en apoyabrazos. Vigilar la colocación de ambos hombros.
- Se fija el paciente al tablero, a la altura de la cadera, con material de sujeción.



- Pierna superior estirada con un cojín / manta entre ambas piernas que igualmente amortigua la caída del pie . Vigilar la presión sobre los testículos.
- Pierna inferior en flexión con apoyo bajo rodilla y tobillo.
- Partir la mesa a la altura del ombligo del paciente, de forma que el tórax quede a la misma altura o más alto que la cresta ilíaca.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO



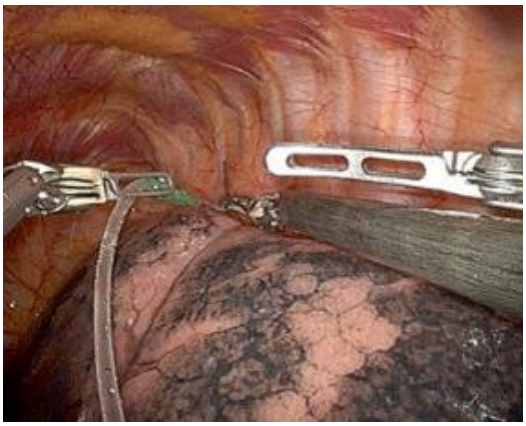


- Anatomía: torácica transversal.
- Lado Derecho Paciente.
  - Brazo 1 - Tip Up.
  - Brazo 2 - Cadiere (Bipolar Fenestrada)
  - Brazo 3 - Óptica 30.
  - Brazo 4 - Bipolar maryland / endograpadora.
- Torre de visión: Considerar pantalla accesoria especialmente si es lado derecho y lóbulo superior.

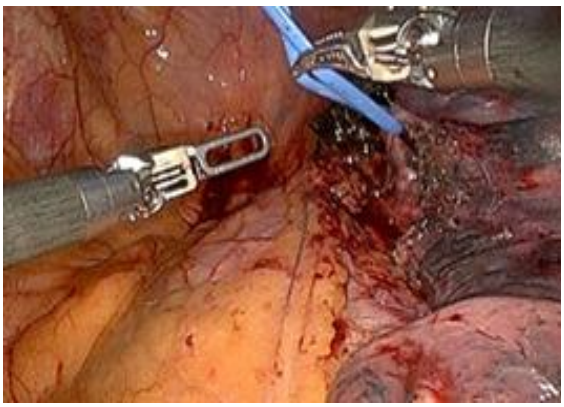
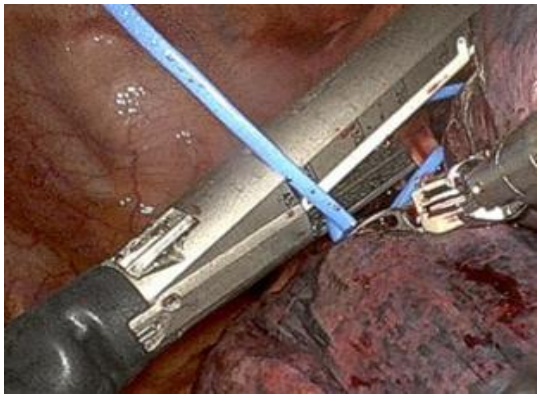
TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Colocación de trócares y realización del neumo con bajo flujo (5 L/min) y presiones entre 6-8 mmHg.

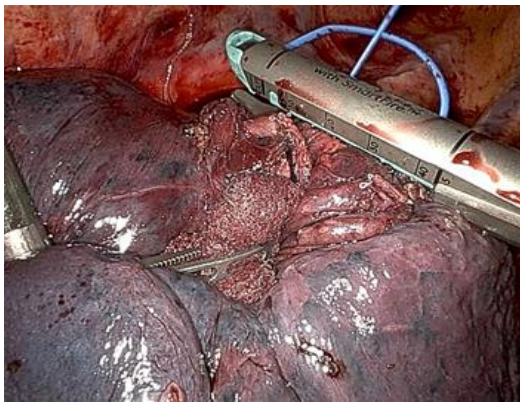
- Inicialmente, para mantener una separación de planos y absorber fluidos, se utiliza material textil. Se recomienda tener preparadas varias unidades de gasa tipo QuirPad (es decir, enrolladas longitudinalmente en forma de cilindro y suturadas para mantener la forma). Además, es aconsejable disponer de varias torundas pequeñas.
- Visualización de la cavidad y realización del bloqueo intercostal si anestesia no ha hecho ninguno previo.
- Liberación de adherencias, si fuese necesario.




- Liberación del ligamento pulmonar y linfadenectomía de las áreas correspondientes.
- Localización, disección y resección del paquete vascular que irriga el lóbulo. Una vez disecado el vaso, se referencia con un vessel-loop azul grueso cortado a un tercio aproximadamente de su tamaño para poder traccionar de él. Se secciona con la endograpadora Sureform blancas de 2.5mm. En esta cirugía, es recomendable tener siempre preparado y disponible algún hemostático sellante como puede ser el Floseal.

- Localización, disección y resección del bronquio lobar con endograpas sureform verdes / negras (4.3mm/ 4.6mm respectivamente). Se referencia y se pasa la grapadora, pero antes de seccionarlo se comprueba la ventilación.



Para ello se cierra la endograpadora sobre el bronquio y se vuelve a ventilación bipulmonar, confirmando que el lóbulo a extirpar no se expande. En este momento se quita el neumo para facilitar la expansión.

- Resección de la cisura pulmonar correspondiente con disección roma y con grapas azules (3.5mm) o verdes si el tejido es muy grueso.
- Embolsado de la pieza.
- Se termina la disección del mediastino y la linfadenectomía.
- Comprobación de hemostasia y extracción de la pieza por incisión de asistencia.
- Comprobación de fugas. Para comprobar las fugas, se sumerge el pulmón en suero fisiológico caliente (1L aprox.) y se ventila con normalidad para valorar la aparición de burbujas. Si aparecieran fugas, en función de la cantidad, se podría reforzar la zona con Tachosil y/o punto de monocryl 3-0, o resecar con endograpadora un poco más de pulmón.
- Colocación de drenaje con blake nº24 a thopaz (o pleurevac) y cierre de las heridas.

BIBLIOGRAFIA

1. HADDAD, Rui; LIMA, Carlos Eduardo T. Cirurgia torácica robótica: segmentectomia pulmonar. *Pulmão RJ*, 2021, vol. 30, no 1, p. 15-19.
2. RAMOS, Larissa Mota; PASSINI, Amanda; DE OLIVEIRA, Gabriel Silva Neto. Cirurgia toracoscópica assistida por robótica (RATS) lobectomia. *Journal Archives of Health*, 2025, vol. 6, no 4, p. e2693-e2693.